Наружные отиты

Клинические рекомендации от 13.11.2024 · взрослые

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **H60.0** Абсцесс наружного уха — фурункул, карбункул, нарыв ушной раковины или слухового прохода
- **H60.1** Целлюлит наружного уха
- **H60.2** Злокачественный наружный отит
- **H60.3** Другие инфекционные наружные отиты — диффузный, геморрагический, «ухо пловца»
- **H60.4** Холестеатома наружного уха
- **H60.5** Острый наружный отит неинфекционный — актиничный, химический, контактный, экзематозный, реактивный
- **H60.8** Другие наружные отиты — хронический наружный отит
- **H60.9** Наружный отит неуточнённый
- **H61.0** Перихондрит наружного уха
- **H61.8** Другие уточнённые болезни наружного уха
- **H61.9** Болезнь наружного уха неуточнённая
- **H62.0** Наружный отит при бактериальных болезнях — при рожистом воспалении
- **H62.1** Наружный отит при вирусных болезнях — при герпесе, опоясывающем лишае
- **H62.3** Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях
- **H62.4** Наружный отит при других болезнях
- **H62.8** Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

Главное

- Наружный отит — воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- Неосложнённый наружный отит лечат местно: ушными каплями, а при бактериальном отите в первую очередь фторхинолонами. Всем нужны туалет слухового прохода и обезболивание.
- Системные антибиотики при неосложнённом отите не назначают. Они нужны при постлучевом отите, сахарном диабете, иммуносупрессии и хондроперихондрите.
- Эффект оценивают через 48–72 часа. Если его нет, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.
- При злокачественном наружном отите сильная боль, грануляции, в посеве синегнойная палочка, лечение не помогает больше недели; чаще болеют пожилые с сахарным диабетом. Нужны глюкоза крови, КТ, госпитализация и антибиотики не меньше 6 недель.

Клиника и классификация

Определение

Наружный отит — воспалительные изменения ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Отит бывает острым и хроническим, если длится дольше 6–12 недель. Диффузный наружный отит включает экзему, дерматит, рожу, герпес, перихондрит, хондроперихондрит и злокачественный наружный отит. Ограниченный — это фурункул и абсцесс.

Воспаление начинается с повреждения кожи: травмы, долгого пребывания во влажной среде, сахарного диабета, дерматита или экземы. Предрасполагают узкий слуховой проход, экзостозы, слуховой аппарат, попадание воды, нарушение образования серы и облучение.

Жалобы

Пациенты жалуются на дискомфорт и боль в ухе, часто сильнее при надавливании и жевании; боль может отдавать в глаз, зубы, глотку. Слух снижается, если слуховой проход полностью закрыт. Иногда беспокоят зуд и выделения. Температура обычно субфебрильная.

Осмотр

При осмотре видны гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи слухового прохода, иногда ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки, а также патологическое отделяемое. При ограниченной форме находят абсцессы и инфильтраты, бывает регионарный лимфаденит.

Особенности форм

Фурункул слухового прохода в стадии инфильтрации вызывает дискомфорт, который усиливается при манипуляциях в ухе, а после формирования абсцесса на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения и иногда снижение слуха.

При экзематозном отите видны желтовато-розовые очаги с чешуйками, беспокоит зуд, иногда сильный и появляющийся раньше высыпаний. Затем образуются микровезикулы, эрозии и мокнутие, причём элементы разных стадий видны одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний появляются жжение, зуд и покалывание, затем эритема, пузырьки и корочки. Обычно всё проходит за 10–14 дней, при вторичной инфекции — за 3–4 недели.

Диагностика

Диагноз ставят по характерным жалобам и клинической картине; при необходимости его подтверждают лабораторно и другими методами.

Отделяемое отправляют на посев на бактерии, на микроскопию и посев на грибы, делают цитологию; при подозрении на новообразование — биопсию.

Мазок берут до начала противомикробного лечения, под контролем отоскопии, тампоном на глубине до 0,3 см из просвета или со стенок слухового прохода, не касаясь его наружных отделов.

Если после стихания воспаления пациент жалуется на снижение слуха, проводят аудиометрию, чтобы исключить острую нейросенсорную тугоухость. При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

КТ и МРТ нужны при осложнённой форме, когда есть костные секвестры или абсцессы, чтобы оценить распространённость процесса. При неосложнённом отите лучевая диагностика не нужна.

Если наружное ухо поражено на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания, пациента направляют к профильному специалисту и дообследуют.

Злокачественный наружный отит

При злокачественной форме определяют глюкозу крови, чтобы выявить сахарный диабет: в 90–100% случаев злокачественный отит сочетается с ним.

Основные признаки злокачественного наружного отита: боль в ухе и головная боль на стороне поражения, отёк стенок и выделения из слухового прохода, грануляции в нём, микроабсцессы в области уха и основания черепа, очаг воспаления на сцинтиграфии, отсутствие эффекта от лечения больше недели и синегнойная палочка в посеве.

Дополнительно учитывают сахарный диабет, поражение черепных нервов, истощение и пожилой возраст. Если сцинтиграфию сделать нельзя, назначают местное лечение на 1–3 недели: отсутствие улучшения говорит в пользу злокачественного отита.

Лечение

Всем пациентам устраняют предрасполагающие факторы, хорошо обезболивают и регулярно проводят туалет наружного слухового прохода.

Местное лечение

Неосложнённый наружный отит лечат местно, препаратами, которые действуют на золотистый стафилококк и синегнойную палочку. Эффект оценивают через 48–72 часа. Если симптомы держатся, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.

При бактериальном наружном отите ушные капли с фторхинолонами — препараты первого выбора.

Ушные капли назначают всем пациентам с бактериальным наружным отитом; варианты — в таблице ниже.

При любой форме применяют антисептики (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом) и противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые. При местном лечении 65–95% пациентов выздоравливают на 7–10-е сутки.

При экзематозной форме назначают кортикостероиды вместе с противомикробными средствами.

Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР — «Комбинил»)	антибактериальный — ципрофлоксацин; противовоспалительный — дексаметазон	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; анестетик — лидокаин	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	антибактериальный — хлорамфеникол; противогрибковый — клотримазол; противовоспалительный — беклометазон; анестетик — лидокаин	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	антибактериальный — фрамицетин + грамицидин; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений

> В этой КР капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, а в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года. Проверьте возраст по инструкции в ГРЛС.

Системные антибиотики

При неосложнённом наружном отите системные антибиотики не назначают: если добавить их к местному лечению, результат не улучшается.

Системные антибиотики нужны при постлучевом наружном отите, сахарном диабете и иммуносупрессии.

Злокачественный наружный отит лечат системными антибиотиками не меньше 6 недель; препараты должны действовать на синегнойную палочку и стафилококк.

При хондроперихондрите ушной раковины назначают системные антибиотики и противовоспалительные средства, чтобы снять боль и отёк.

Хирургия и другое

При ограниченном отите вскрывают и дренируют абсцессы слухового прохода. При злокачественном удаляют грануляции, костные и хрящевые секвестры и холестеатому в пределах зоны поражения.

Для повышения эффективности лечения применяют физиотерапию.

Посевы повторяют до тех пор, пока не подтвердится, что возбудитель исчез.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе контролируют уровень глюкозы крови.

Профилактика и госпитализация

Для профилактики советуют реже пользоваться ватными палочками и не чистить слуховой проход слишком часто, а также соблюдать гигиену берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечат обычно амбулаторно, а при некротическом (злокачественном) наружном отите госпитализируют. Выписывают, когда воспаление в слуховом проходе стихло и гнойно-септических осложнений нет.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

Неточности в самом тексте КР

- Норфлоксацин в каплях: здесь — с 15 лет, в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года.
- В таблице 1 у фрамицетина с дексаметазоном антибактериальный компонент назван «Грамидин»; по названию препарата — грамицидин.
- Одна строка таблицы 1 дана торговым названием «Комбинил» (ципрофлоксацин + дексаметазон).
- Сокращение «зО» в разделе 2.5 — по смыслу злокачественный наружный отит.